

Fecha Última Actualización: 17-11-2022 16:52:40

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Rosa Elena Melo Molina
Edad : 79a 8m 4d
Dirección : Anita Lizana 376 Pb Maipo 0

Rut : 6.039.977-8
Fecha Nacto: 13/03/1943
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A035891
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8749 5173

N° Epicrisis
330626

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Traumatología Y Ortopedia

Fecha Ingreso : 26/09/2022 18:09

Días Estadía: 52

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 17/11/2022 16:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor hombro derecho

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso UPC
07/11/2022

Datos del Paciente
Nombre: Rosa Elena Melo Molina
RUT: 6.039.977-8
Edad: 79 años
FI HSR: 26/09/2022
FI UTIM: 17/10/2022
FI UCI: 07/11/2022

Motivo de consulta: Disnea.

Antecedentes:

Médicos: HTA, ICC, HTA, Infección de herida Qx de hombro (fractura intra-operatoria de prótesis reversa e infección post-quirúrgica).

Quirúrgicos: Fractura conminuta de hombro derecho 05/2021, necrosis avascular de hombro derecho 06/22 y el 08/22 se logra pabellón para resolver no-unión humeral, presentando Fx de húmero y glenoides, queda con vástago y cemento en espera de 2° tiempo Qx.

Fármacos: Losartan 50mg, Carvedilol 6.25mg, Furosemida 20mg, Hidroclorotizida 12.5mg, Paracetamol, Celecoxib.

Alergias: No.

Hábitos: TBQ (+) 4cig/día, OH ocasional, drogas niega.

Hospitalizaciones recientes: No.

Anamnesis:

Paciente de antecedentes descritos, historia comienza 06/2021 cuando presenta caída a nivel con fractura proximal de hombro D°.

Posteriormente al año se presenta en controles de TMT con hombro doloroso, objetivándose necrosis avascular de cabeza humeral y no-unión de fractura reducida con osteosíntesis, queda en planificación quirúrgica que se logra concretar el 01/8/22, presentando intra-pabellón fractura de diáfisis humeral y glenoides, quedando con vástago + cemento a la espera de 2° tiempo quirúrgico.

Fecha Epicrisis : 17/11/2022 16:52

Página 1 de 4

En postoperatorio (domicilio) evoluciona con abundante secreción purulenta evidenciada en curaciones, reingresa el 22/8 para aseo Qx y luego el 26/8 es reintervenida para instalar VAC excisional, que se retira 13/9 y se aísla en cultivos óseos del 1er aseo S. aureus MS, S. haemolyticus MS y P. mirabilis, quedando con Cefadroxilo + Ciprofloxacino a completar por 6 semanas en domicilio, tras evaluación por Infectología y cultivos de aseo Qx control negativos del 05/9.

En controles ambulatorios, se evidencia nuevamente con secreción sero-hemática que evoluciona a purulenta, con elevación de parámetros inflamatorios, por lo que reingresa nuevamente para manejo intrahospitalario ante falla del tratamiento ambulatorio.

Ingresa el 26/9/22 para aseo Qx, se evidencia gran hematoma en región axilar y hombro, se envían muestras a cultivo del hematoma y tejido óseo y mantiene esquema ATB propuesto por indicación de Infectología.

El 03/10 con nuevo lavado y retiro de material de osteosíntesis, cemento y fragmento óseo de aspecto osteomielítico.

En seguimiento por Infectología, se rescatan cultivos de pabellón: 27/9 (hematoma) (+) S. haemolyticus MR y 03/10 (hueso) (+) S. hominis MR, dado sospecha de RAM a B-lactámicos (presentó rash) se indicó TMP-SMX y luego se escala a Vancomicina.

Paciente el 05/10 presenta deterioro ventilatorio asociado a peak febril, se toma angioTC de Tx 08/10 que informa osteomielitis glenohumeral e infiltrados bilaterales compatibles con neumonía por COVID19, se tipifica PCR (+) 07/10.

Se maneja con O2 y KTR, evolucionando favorable, manteniéndose estable con requerimientos de O2 a la baja hasta el 14/10 que presenta progresivo aumento de requerimientos de O2 y falla renal, evaluada por Medicina Interna se indicó volumen, BD y ICS.

Paciente se mantuvo con aporte continuo de sol. Salina, evolucionando congestiva, edematosa y con mayor insuficiencia respiratoria, requiriendo conexión al VMNI el 17/10, motivo por el cual se traslada a PAM a continuar manejo

Evolución durante estadía en UTIM/TMT

HDN/CV: Se rescata antecedente de ICC usuaria de furosemda e hidroclorotiazida, se desconoce CF, FEVI o etiología. A su ingreso a a UTIM con hipervolemia y EPA congestivo en contexto de sobrevolemización, se conectó a VMNI y se indicó terapia depleitiva, con buena respuesta. En contexto de intercurrentia respiratoria/infecciosa el 29/10 evoluciona con mala perfusión clínica, se suspende terapia depleitiva y se volemita con buena respuesta. Posteriormente desde el día 05/11 se describe con tendencia a hipotensión e hipoperfusión, con requerimientos de NAD hasta 0.15 ug/ kg/min. Cursando con shock más probablemente atribuible a shock distributivo (séptico) que obstructivo secundario a TEP (se describe sin sobrecarga de cavidades derechas, pendiente TUS).

Ventilatorio: Traslada a PAM por insuficiencia respiratoria aguda, en un inicio explicada por NIH COVID19 al que se le agrega componente de sobrecarga de volumen. Buena respuesta a terapia depleitiva y conexión a VMNI inicial, pero persiste con altos requerimientos de O2 por lo que se conecta a CNAF una vez resuelto componente congestivo y se inicia protocolo recovery, evolucionando con buena respuesta de lo ventilatorio. Disminuye requerimientos de oxígeno y se traslada nuevamente a TMT. Evoluciona el 28/10 con dificultad respiratoria, aumento de requerimientos de oxígeno, signos de mala perfusión clínica y fiebre. Se toma AngioTC que descarta TEP y describe leve progresión de los signos de neumopatía multifocal bilateral; con posterior recuperación. Frente a nueva intercurrentia infecciosa, paciente presenta nuevo deterioro clínico llegando a requerir IOT, sedación profunda y VMI. Previo a su traslado se describe PAFI 193, CO2 50 pH 7.15, VT a 300cc (7 ml/kg), PEEP 8. Autopeep 2. FR 24 Ti 0.7 Pmes 22 DP 14. TOT insinuado bronquio derecho, se retira 2 cm, se fija a 20 cm comisura en control con radiografía de tórax a las 16:30.

Infeccioso: Osteomielitis e infección de herida operatoria, cultivo de hematoma capsular (+) S. haemolyticus MR y cultivo óseo (+) S. hominis MS, evaluada por Infectología se indicó Vancomicina EV ajustándose según niveles plasmáticos. En relación a intercurrentia del 29/10 se toman HC I y II que se informan positivos para BGN a las 22 hrs (PAE 22 horas R imip/merop S AK ciproflo piperac/T). Aseo del 3/10/2022 se describe retiro de placa y tornillos y en aseo qco del 1/11/2022 retiro de material necrótico y coágulos. Del tejido KPN BLEE abundante test carbapenemasa negativo S Ak colistin (0.5) -imip- merop CIM tigeclina <0.5 R cefalosporinas 3G/ampic-s/Piperac-T.

Se describe episodio de shock séptico el 29/10 con posterior evolución favorable y nuevo quiebre clínico desde el fin de semana previo a su ingreso a UCI; evolucionando con shock séptico de foco partes blandas. Se escaló terapia para cobertura

Fecha Última Actualización: 17-11-2022 16:52:40

Página 3 de 4

de microbiología aislada con Meropenem/Ciprofloxacino/Vancomicina.

TMT: Seguimiento por equipo de hombro, el 24/10 se instala VAC en herida de hombro derecho. Seguimiento por equipo.

Diagnósticos actuales:

Shock séptico obs foco pulmonar

Bacteriemia BGN + CGP en tipificación

Insuficiencia respiratoria aguda

·Obs NIH

Infección de herida operatoria y prótesis de hombro D°

·Osteomielitis gleno-humeral D° por S. haemolyticus MR + S. hominis MR (cultivos 27/9 y 03/10)

Antecedentes: HTA, ICC, HTA.

Planes

HDN: Tendencia a la hipotensión en contexto de sepsis, con buena respuesta a volemicización (1000 cc), se solicita instalación de LA. Control de AL, volemicizar según metas e inicio de DVA según necesidad.

CV: Suspendo terapia depleitiva y BB en contexto de compromiso hemodinámico.

Respiratorio: Insuficiencia respiratoria aguda en contexto de shock séptico de posible foco pulmonar, actualmente con NRC. BD + KTR, titular a la baja.

Infeccioso: Cursando shock séptico de posible foco respiratorio según hallazgos de TAC TAP, con HC 1 y 2 (+) a las 22 horas para BGN y CGP en racimo en tipificación. Se mantiene Imipenem + Vancomicina en dosis ajustadas, rescatar cultivos.

TMT: Seguimiento por equipo para definir nueva necesidad de aseo quirúrgico.

Diagnóstico de Egreso

CHOQUE SÉPTICO - OMA hombro derecho

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

DIAGNÓSTICOS:

1. Shock séptico foco partes blandas SOFA ingreso 9

Infección de herida operatoria y prótesis de hombro D°

Cultivo tejido mamario KPN BLEE R Ertapenem

Osteomielitis gleno-humeral D° por S. hemolyticus MR + S. hominis MR (cultivos 27/9 y 03/10)

2. ITS CVC por PSAE R Mero, Imi, S resto (F. HC 28/10)

3. Insuficiencia respiratoria aguda

Neumonía asociada a VM

TEP subsegmentario basal derecho sin TACO

EPA resuelto

HTP

4. Necrosis antebrazo y mano izquierda.

5. AKI KDIGO II obs. prerrenal en TRR

6. Anemia severa microcítica hipocrómica

7. Acidosis metabólica AG aumentado

8. Coagulopatía en estudio

9. Antecedentes: HTA, ICC, HTA.

Paciente fallece a las 11:35 AM del día de hoy, en contexto de disfunción circulatoria severa. Se da aviso a familiares, entienden situación.

Plan Post Alta

-

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

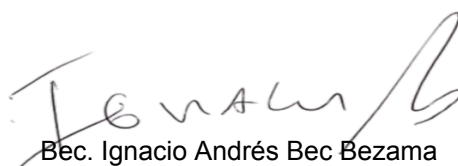
Fecha Epicrisis : 17/11/2022 16:52

Página 3 de 4

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Bec. Ignacio Andrés Bec Bezama

Becado/Residente



Andres Aquevedo Salazar

Médico Tratante (Staff)